

B-42 /Décrypter le lien caché entre anomalies vasculaires et microalbuminurie chez les patients diabétiques

N. KHODJA (1), A. KHODJA (2), I. LAÏDOUNI (2), S. BENSALEM (2)

(1) Laboratoire central/unité de biochimie-Hôpital Militaire Régional Universitaire de Constantine
(2)Service de médecine interne/unité d'endocrinologie diabétologie et maladie métabolique-HMRUC

INTRODUCTION:

- L'indice de pression systolique (IPS) est aujourd'hui un outil de référence pour repérer une artériopathie oblitérante des membres inférieurs, tandis que la microalbuminurie signe une atteinte précoce de l'endothélium et annonce un risque cardiovasculaire accru.
- Chez le patient diabétique, ces deux marqueurs pourraient bien traduire un même processus de souffrance vasculaire. C'est cette hypothèse que nous avons voulu explorer, dans l'espoir d'affiner la stratification du risque cardiovasculaire dans cette population.

PATIENTS ET MÉTHODES:

- Nous avons mené une étude prospective sur six mois, de juin à novembre 2024, incluant 45 patients diabétiques suivis au service de médecine interne de l'Hôpital Militaire Régional Universitaire de Constantine. Les patients ont été répartis en trois groupes selon leur statut d'albuminurie — normoalbuminurie, microalbuminurie et macroalbuminurie — puis nous avons recherché un lien statistique entre ces groupes et l'indice de pression systolique.
- L'analyse statistiques a été effectué par SPSS 19.

RÉSULTATS:

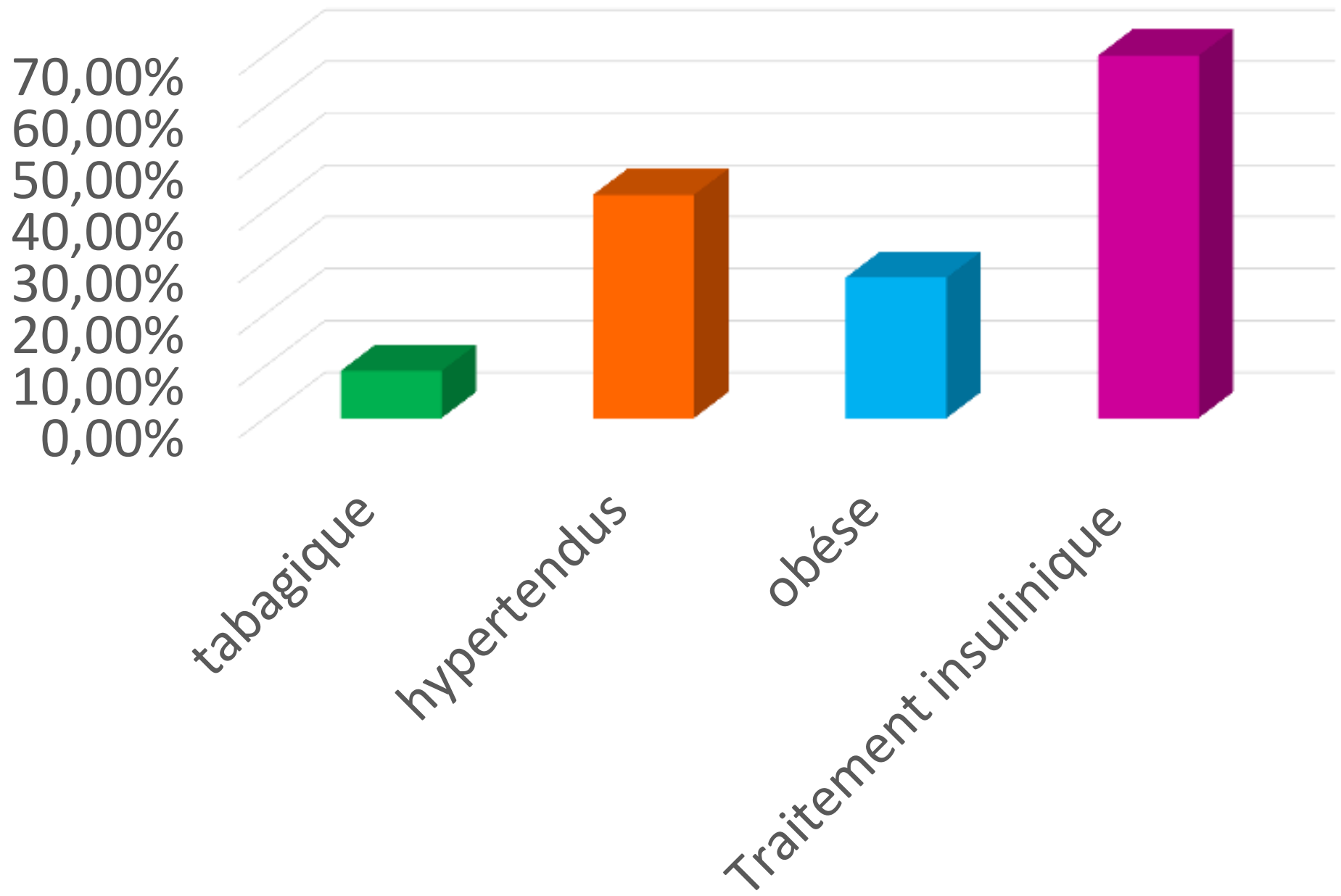
- Population:** 45 patients diabétiques

- Caractéristiques générales de la population:**

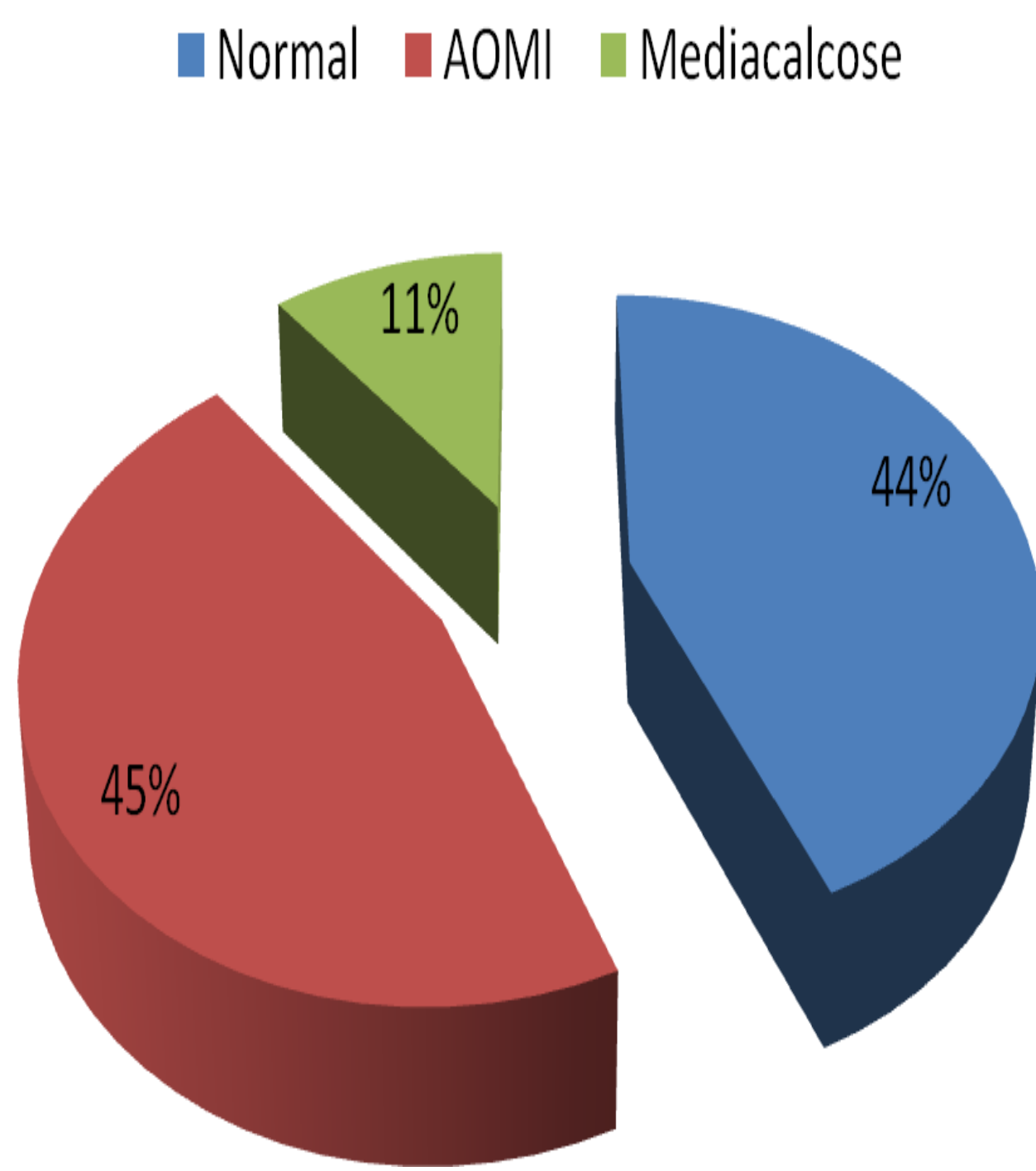
Sexe ratio	0.34
Moyenne d'âge	56 ans
Les extrêmes d'âges	19 - 77 ans
Durée moyenne d'évolution:	10 ans (1an- 27ans).

- patients présentant un **IPS > 1,3** (ou une médiacalcosé):
 - 66,7 % avaient une microalbuminurie
 - 33,3 % une macroalbuminurie (p < 0,02)
- patients présentant un **IPS <0,9**:
 - 62,5 % restaient normoalbuminuriques
 - 37,5 % présentaient une microalbuminurie (p < 0,04).
- Micoalbuminurie positive (> 30mg/j) :chez 53% des patients**

repartition des patients selon leurs facteurs de risques



Résultats de dépistage d'AOMI par IPS



DISCUSSION:

- Les malades ayant une microalbuminurie positive ont 21% plus de risque d'avoir un IPS <0,9 par rapport à ceux ayant une microalbuminurie négatif (Odds ratio=1,21), ce qui suggéré la nécessité d'une recherche intensive pour la présence de l'autre.
- L'atteinte vasculaire dépister par IPS pourrait représenter l'athérosclérose impliquant non seulement les systèmes vasculaires des membres inférieurs , du cœur et du cerveau mais aussi les systèmes vasculaires du reins , ce qui pourrait causer la fuite d'albumine .
- Alors que la corrélation numérique entre IPS <0,9 et
 - microalbuminurie positive n'est pas statistiquement significative (p =0,5) , ce qui peut être expliquer par la taille d'échantillon.
- L'IPS est utile pour le dépistage de la maladie artérielle périphérique chez les patients à risque. Cet indice prédit également le risque d'événements cardiovasculaires.
- L'IPS est marqueur simple qui fournit à la fois une orientation diagnostique et pronostique chez des patients à risque, d'autant plus chez un patient avec microalbuminurie positive .

CONCLUSION:

- ☐ Ce lien entre élévation de l'excrétion urinaire d'albumine et anomalies de l'IPS confirme, une fois de plus, combien dysfonction vasculaire et risque cardiovasculaire sont intimement liés chez le patient diabétique.
- ☐ Ces résultats plaident pour une approche de dépistage combinant IPS et microalbuminurie, deux outils simples et complémentaires, dont la surveillance systématique pourrait permettre de repérer plus tôt les complications vasculaires et d'améliorer la prise en charge de cette population à haut risque cardiovasculaire.

RÉFÉRENCES:

1The association between urinary albumin excretion and ankle-brachial index in elderlyTaiwanese patients with type 2 diabetes mellitus.CHIN- HSIAO TSENG et al.Age and Ageing 2008; 37: 77–82
2Inflammation and Oxidative Stress are Associated with the Prevalence of High Aankle-brachial Index in Metabolic Syndrome Patients without Chronic Renal Failure Yinyin Zhang et all International Journal of Medical Sciences 2013; 10(2):183-190.Hand.